

K

疼痛緩和治療

palliative medicine for pain relief

到達目標

- 「がん疼痛の薬物治療に関するガイドライン」の内容を概説できる
- WHO がん疼痛ガイドラインによるがん疼痛緩和の原則を概説できる
- がん疼痛に対する鎮痛薬の特徴を理解できる
- がん疼痛に対する鎮痛薬以外の治療法を理解できる

1 概説

がんの治療にあたる医師は、患者の症状緩和とがんそのものに対する治療を並行して行う必要がある。がん治療に携わる者が提供する緩和ケアは「基本的緩和ケア」と称され、2006年に施行されたがん対策基本法に基づく緩和ケア研修（PEACE研修）においてもロールプレイに組み入れられるなど、がん治療医がまず行うべき緩和治療として認識されている。日本緩和医療学会は、2020年には「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020年版」を発行した¹⁾。肺癌診療にかかわることの多い呼吸器内科医は、疼痛緩和治療を含む緩和薬物治療にも精通していることが必要かつ重要となる。

がん患者の訴える痛みの中には、①がんそのもの（がん疼痛）、②がん治療に伴うもの、③がん・がん治療とは無関係な病態や後遺症がある。がん疼痛に限っても、その性質は複雑なものが多い。がん疼痛に対しては、その原因や性質、頻度や程度など包括的評価が必要であるが、その評価は医師だけに限らずがん診療に係る医療者チームで行うことが効率的である。治療のタイミングについては、いかなる原因であっても多くの場合共通する疼痛治療を速やかに開始するべきである。

がん疼痛に対する薬物治療は世界保健機関（WHO）は三段階除痛ラダーに準じて治療を行う「WHO方式がん疼痛治療法」を作成し、1986年にその普及をはかる「がんの痛みからの解放」を刊行したが²⁾、2018年にWHO がん疼痛ガイドライン（「WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults

and adolescents」）に変更された³⁾。WHO がん疼痛ガイドラインは、オピオイドを含むがん疼痛治療法のさらなる普及だけでなく、安全性に関しても幅広く網羅され世界的な視点に立脚したガイドラインである。われわれは、がん疼痛を緩和する薬剤について、その効果と有害事象をよく理解し、放射線治療や神経ブロックなどの非薬物療法についても理解を深め、がん疼痛の緩和に向けたチーム医療を提供できるスキルを有する必要がある。

2 がん疼痛の種類

がん疼痛には、痛みの性質による分類、痛みのパターンによる分類があり、治療方針を決定するために行う痛みの包括的評価ではどちらの分類も必要である。また、痛みの臨床的症候群には、緊急性を有するオンコロジーエマージェンシーとなるものがあるため、臨床医は常にこれらを鑑別に挙げ、実際にそうであった場合は適切かつ迅速な初期対応をできることが要求される。

a 痛みの性質による分類

がん疼痛は、侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛に大別される。侵害受容性疼痛はその部位により体性痛と内臓痛に分けられる。体性痛は皮膚や骨などの体性組織への機械的刺激で発生する痛みで、腫瘍が存在する局所での組織破壊とそれに伴う炎症が原因と考えられ、原因部位は圧痛個所として認識できることが多い。内臓痛は消化管の炎症や閉塞、肝臓などの実質臓器の圧迫、臓器皮膜の急激な進展などによって生じる。神経障害性疼痛は末梢・中枢神経の直接的損傷に伴って発生する痛みである。障害された神経の支配領域にさまざまな痛みや感覚異常を伴うことが特徴である（表1）。

b 痛みのパターンによる分類

痛みには1日の大半を占める（24時間のうち12時間以上経験される）持続痛と、一過性の痛みの増悪として表現される突出痛がある。突出痛にはその出現が予測できる場合とそうでない場合がある。予測できる痛みの代表は、身体動作に伴って生じる体動痛であ

表1 痛みの性質による分類

分類	侵害受容性疼痛		神経障害性疼痛
	体性痛	内臓痛	
障害部位	皮膚、骨、筋肉など	消化管、肝臓など	末梢神経、脊髄神経など
原因	機械的刺激、炎症	管腔内圧上昇、皮膚伸展、炎症	神経圧迫、神経損傷
特徴	局在が明瞭、持続痛＋体動痛	局在が不明瞭、持続痛＋突出痛	局在が障害神経領域、感覚異常を伴う
具体例	骨転移による痛み	肝転移による右季肋部・上腹部痛	肺炎肺がんによるしびれを伴う上肢痛